

Pflege von Menschen mit chronischen Wunden

Dokument	Flussdiagramm	Verantw.	Bemerkung
----------	---------------	----------	-----------

1. Pflege-dokumentation

2. Pflege-dokumentation (*)

Assessment zur Einschätzung der wund- und therapiebedingten Einschränkungen/Selbstmanagement-kompetenzen

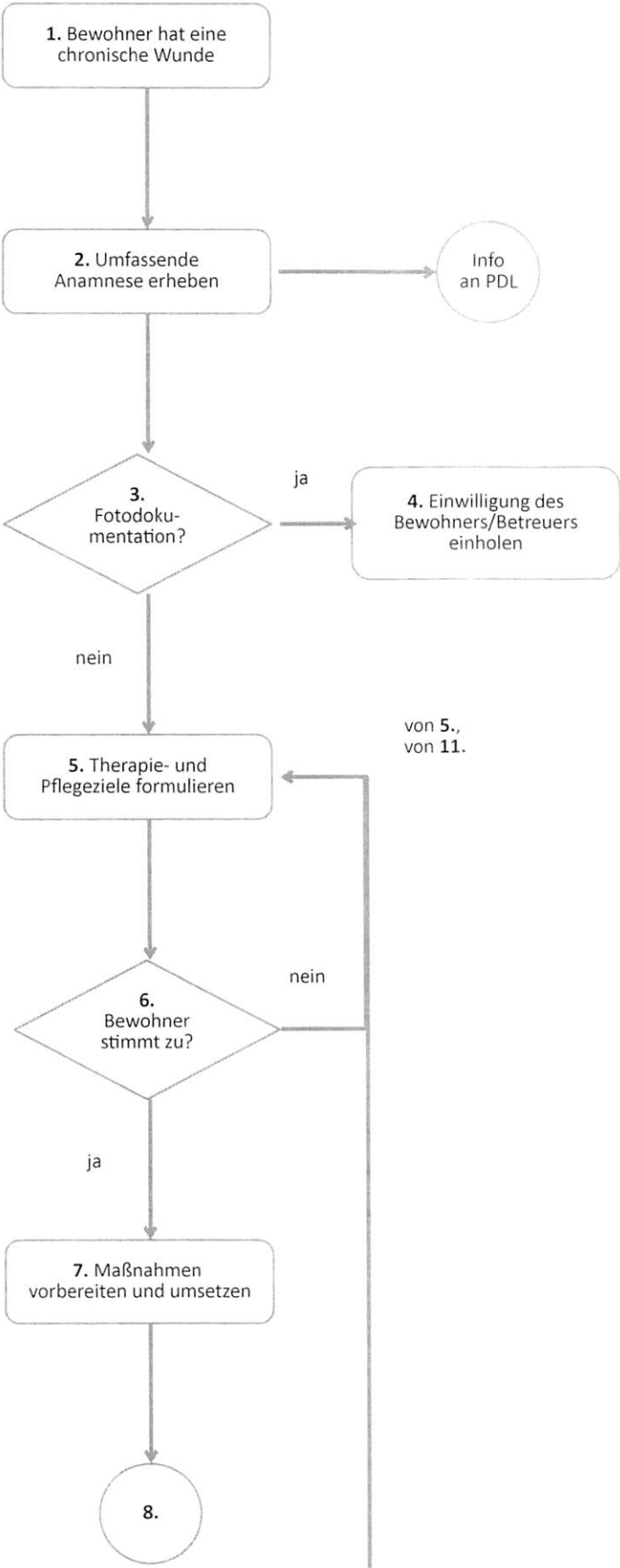
3. Anleitung Fotodokumentation

Einverständniserklärung zur Fotodokumentation

5. Pflege-dokumentation

Wunddokumentation

7. Ärztliche Verordnung



PFK/WM
1. Die Wunde besteht seit vier bis acht Wochen, die Haut und/oder die darunterliegenden Hautschichten sind geschädigt. eine Wunddokumentation wird sofort bei Feststellung einer Wunde angelegt.

PFK/WM/Arzt
2. Innerhalb von 24 Stunden nach Feststellung der Wunde wird eine Wundvisite durchgeführt, in der die Anamnese erstellt wird. Sie enthält: Wissen des Bewohners über Krankheitszusammenhänge, Einschränkungen, Selbstmanagement, vollständige Wunddokumentation. Info an PDL zur statistischen Erfassung.

PFK/WM
3./4. Das Einverständnis des Bewohners muss vorliegen. Das Foto wird nach dem festgelegten Standard erstellt. Alle benötigten Utensilien liegen bereit.

von 5., von 11.
PFK/WM/Ärzte/Andere
5. Die PFK übernimmt zwischen den verschiedenen Berufsgruppen die Koordination der Versorgung. Das können z. B. die Ernährungsberatung, eine Anleitung und Beratung, die Hilfsmittelversorgung, ein Podologe sein. Ein gemeinsamer Versorgungsplan wird erstellt.

PFK
6. Die PFK bezieht den BW in verständlicher Weise mit ein und berücksichtigt seine Wünsche und Bedürfnisse im Maßnahmenplan.

PFK/PK/andere Berufsgruppen
7. Neben der Wundversorgung können das z. B. Maßnahmen zur Druckentlastung, Hautpflege, Kompressionsverbände, Schmerzmanagement sein. Der Zeitpunkt des Verbandwechsels ist zeitlich terminiert und in den Tagesablauf integriert.

8. Informations- für Bewohner und Angehörige zu chronischen Wunden

8. Selbstmanagement bei Bewohner/Angehörigen fördern

PFK/PK/
andere
Berufs-
gruppen

8. Das Selbstmanagement beinhaltet allgemeine Hinweise zur Verbesserung der Lebensqualität oder zum konkreten Umgang mit der Krankheitsbewältigung.

9. Pflege-
dokumentation
Assessment zur
Einschätzung der
wund- und
therapiebedingten
Einschränkungen/
Selbstmanagement-
kompetenzen

9.
Evaluation

PFK/WM

9. Gemeinsam mit dem Wund-
manager in festgelegten Intervallen,
spätestens nach vier Wochen.
Es beinhaltet, wie unter 2.
beschrieben, eine umfassende
Auswertung.

Kriterien für ein
wundspezifisches
Assessment

10.
Anpassungen
erforderlich?

PFK

10./11. Erforderliche Anpassungen
werden mit allen Berufsgruppen
und dem Bewohner/Angehörigen
abgestimmt und umgesetzt.

zurück zu
5.

11. Pflege-
dokumentation
Wund-
dokumentation

11. Therapie- und
Pflegeplan weiter umsetzen

14.
Fragebogen zum
Fortbildungsbedarf
Erfassung chronischer
Wunden

12.
Wunde
abgeheilt?

PFK/WM

12./13. Gegebenenfalls ein
Abschlussfoto anfertigen, Wund-
dokumentation abschließen.
Maßnahmen zur Verhinderung
eines Rezidivs werden weiter
fortgeführt.

nein

Maßnahmenplan zur
Verbesserung des
Gesamtprozesses
Konferenzen-/
Vereinbarungs-protokoll

ja

13. Wundversorgung
abschließen

14.
Gesamtauswertung

PDL

14. Ermittlung von Kennzahlen und
regelmäßige Auswertung des
Gesamtprozesses.